

On va prendre les deux aortes primitives, au milieu, il y a des tissus d'intérieur, ici, nutritifs. Vous vous souvenez, l'embryon, qu'est-ce qu'il fait ? Il grandit. C'est le référent influent acneurale, qui elle, devient une gouttière. Dans cette formation d'une gouttière, ça crée une trajectoire. Cette trajectoire commence à devenir deux petits conduits aortiques primitifs. Et on voit que l'embryon, il fait un mouvement de flexion, de rotation interne, d'adduction. Un mouvement développemental où il revient vers le centre. Simplement parce qu'à un moment donné, j'ai mes aortes qui se développent ici, et que j'ai un processus de télécephalisation qui tire vers l'arrière et que tout se rapproche vers l'avant. Dans cette phase de rapprochement vers l'avant, j'avais au départ, embryologiquement, deux tubes qui étaient là. Et ces deux tubes vont venir vers la ligne médiane, et à un moment donné, vont se fusionner. Cette phase de fusion, ici, tu vois que par ce processus, ça commence à venir l'un contre l'autre, comme ceci. Là, il y a encore un peu de tissu d'intérieur, pas de problème. Là, il y en a de moins en moins. Et à un moment donné, les deux tissus, ici, vont vraiment être l'un contre l'autre. Comme il n'y a plus de tissus intérieurs, il y a un champ de corrosion qui attend. Vous avez énormément de choses comme ça qui se font dans le corps. Un exemple, au départ, je suis comme ça, j'ai ce qu'on appelle des arcs branchiaux. Quand j'ai une flexion de l'embryon, on voit apparaître à l'extérieur, sur l'ectoderme de surface, à la partie intérieure, une compression. On voit ça avec mon doigt, et on voit que ça fait des arcs branchiaux. À un moment donné, ici, il y a un arc branchial qui subit, contre le cœur, avec la mandibule, une pression. de données ici. qui fait que ça va ouvrir ici un espace, la bouche. Ça, c'est, par exemple, un exemple d'un champ de corrosion. Par exemple, maintenant, quand on dépasse... Par exemple, maintenant, Une limite, un exemple d'un champ de corrosion, tu es hospitalisé, tu es couché dans ton lit pendant 15 jours, 3 semaines,

qu'est-ce que tu commences ? Tu commences un escalier. Tu as une pression, tu as la pression qui continue, tu as le sang sur le côté qui s'en va, et en fait tu n'as plus d'aspect trophique. Tu commences à avoir un échauffement d'abord, et puis à un moment donné tu as un champ de corrosion. C'est une nouvelle structure qui apparaît. Et ce phénomène de champ de corrosion, dans ton système, du développement du système vasculaire, vous allez voir qu'elle est très importante. Ça change tout le temps. Au départ tu as ce qu'on appelle les veines cardinales, antérieures, enfin, postérieures, antérieures, puis ça va devenir des veines subcardinales, puis supracardinales, et tu vas avoir toute une réorganisation de ton corps en fonction de ça. En fonction de ta croissance, etc. Simplement des champs, et puis tu as les artères spinales, tu as des vaisseaux postérieurs, etc. Au départ tu as une structure, et puis par ces champs de compression, de décompression, etc., de nouvelles structures apparaissent, c'est ce qu'on appelle un champ de corrosion. Donc c'est comme le mot destruction, je n'aime pas, c'est un changement de forme. On va voir le champ, ce qu'on appelle le « loosening kill », un champ d'aspiration. Ce champ, on va vous expliquer, un champ de succion. C'est le même schéma pour toutes les glandes du corps. Ce type de champ apparaît toujours le long des surfaces des tissus épithéliaux, soit d'origine ectodermique, soit d'origine endodermique. Je vais prendre un exemple d'un tissu épithélial de type endodermique. Et en dessous, qu'est-ce que j'ai ? J'ai du tissu de type conjonctif. Quel y a des vaisseaux, quel y a des petites lampes, quel y a de la matrice, quel y a des fibres, etc. Alors, on voit apparaître, le long des surfaces, à un moment donné, dans un tout premier temps, une phase congestive. Donc, comme s'il y avait de l'accumulation, comme si c'était un peu d'eau qui venait. L'image, c'est comme si je marche sur la plage, tu vois, et à un endroit où le sol, il est un peu, tu vois, c'est un peu comme congestionné, mais quand tu marches dessus, tu sens qu'il

peut partir dedans. C'est comme si c'était dans l'ébauche, c'est dans le moment, au départ, c'est une activité, j'arrive, et tout d'un coup, il y a du sable mouvant. On va prendre le poumon. Vous vous souvenez de la mise en place du diaphragme. Il y a un espace ici derrière, parce que j'ai mon... j'ai déjà... on va dire... mon tube digestif, et derrière, ici, il y a, sur ce tissu ici, derrière, j'ai ce phénomène qui se passe ici. J'ai une fragilisation. Et puis, à un moment donné, par la croissance de l'embryon, j'ai le redressement, l'allongement de mon embryon, la croissance ici, il y a un espace qui s'ouvre ici, et ça crée un champ de... Tu vois, où il y a le tissu qui est là, épithélial, il est comme aspiré dans cet espace. Tu vois ? Tu comprends ce que je veux dire. C'est vraiment comme une ventouse. Vraiment comme une ventouse. Je grandis, j'ai... j'ai grandi j'ai... Je tire vers moi, un champ de succion, j'aspire. Le tissu épithélial, tout d'un coup, hop, il descend dans le tissu conjonctif. Il est comme aspiré dans le tissu conjonctif. Première phase, on voit qu'il est aspiré dans le tissu conjonctif. Il s'effondre dans le tissu conjonctif. Un champ d'aspiration. Il est toujours autour de la tissu conjonctif. Puis là, je vais me retrouver avec deux types de mouvements. Soit la cellule descend et crée vraiment comme une glande, comme ceci. C'est bon ? Et là, ça va s'appeler une glande exocrine. Les cellules vont sécréter une substance qui va être mise dans la lumière qui est créée par ici, le tube. Par exemple, la vésicule biliaire est une glande de type exocrine. Ou si ça va plus loin dans le champ métabolique, ça va créer ce qu'on appelle une glande houleuse. Ici, ça disparaît et il reste juste une glande en plein milieu. Ça, ça va s'appeler une glande endocrine. Ça veut dire qu'elle va sécréter la substance à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a tout mon réseau vasculaire. Je vais prendre là, dans le centre. Par exemple, sur le poumon, ça reste. Sur le foie, ça reste, mais sous le pancréas, vous avez deux pancréas, vous avez le pancréas exocrine, le pancréas endocrine, c'est un champ métabolique, qui s'est développé

dans un champ d'aspiration qui s'est fait dans le même moment, mais l'image, c'est qu'il y en a qui ont été plus loin ici, ils ont perdu leur correspondance, ce sont devenus de simples petits îlots, de petites glandes à l'intérieur du système, ils fabriquent un autre plan métabolique de type amylase, lipase, etc. Tandis que les zones, c'est une glande qui va fabriquer le système de l'insuline, par exemple. Les poumons, il faut les considérer comme une glande, c'est une glande respiratoire. C'est le même algorithme de développement, mais dans des espaces et dans une chronologie différente. Ils sont négatifs au niveau pulmonaire. qui est maintenu par le système. Si je coupe la brèche du système pariétal, le poumon, il redevient dans sa forme au départ. C'est pour ça qu'on crée le vide. Et en fait, c'est des mécanismes d'aspiration, c'est du vide qui maintient. Ce n'est pas une différence de champ métabolique, c'est une différence de croissance. Donc c'est le même champ, mais ça ne compte pas. Le même champ, sauf qu'il y en a un autre. C'est le même champ, sauf qu'il y en a un qui va... C'est un peu plus fort, il perd sa connexion. C'est toi aussi qui peux le connaître. C'est tous les organes qui sont d'origine épithéliale. Mais la vie au départ, c'est comme un grand champ d'aspiration. L'environnement et la réponse génétique. Au départ, tu as l'environnement, et sur le tissu, tu as plein de molécules qui vont libérer des morphogènes, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais qu'est-ce qui est lié à l'environnement ou aux champs électriques ? Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui est lié à l'environnement ou à ta carte de la vie ? Donc là, on a vu, par exemple, le premier champ métabolique, c'était comment ça va organiser des champs de corrosion pour créer une nouvelle structure. Le cas extrême d'un champ de corrosion, c'est un escarpe, mais là, il y a une destruction, mais c'est une destruction du tissu d'intérieur. C'est pour ça que l'autre côté, c'est aussi une destruction du tissu d'intérieur, avec l'apparition d'une nouvelle structure. Tandis que dans l'escarpe,

c'est juste le tissu d'intérieur qui est écarté. Par ce processus, on commence à percevoir comment, dans l'embryon qui se construit, comment dans l'embryon va apparaître, en fonction de votre génome, en fonction de l'espace et du temps, des différents champs métaboliques qui vont commencer à participer à cette création. Chacun a un champ métabolique. Si je vais trop loin dans un système, je vais perturber tout ce champ là-bas. C'est ça l'idée de la garantie homéostasique. Chacun doit à un moment donné atteindre son état d'équilibre. Ceci est un champ de dilation. On est dans une structure qui se construit. J'ai un tissu de type, à un moment donné, un tissu mésoblastique qui apparaît. Il part, qui est à une certaine périphérie. Il part, à un moment donné, la croissance. Je tire sur le tissu, et le tissu va commencer à s'allonger à un endroit. Mais il garde encore son élasticité. Et donc il se remplit de l'élastine, il garde son élastine. Et si maintenant je passe à un autre champ, je vais plus loin que je tire ce champ là, je vais sur un autre type de tissu. En fonction du champ qu'il va recevoir, dans la croissance où il sera mis dans l'espace, comment il va s'organiser. Je vais plus loin qu'un champ de dilation, je vais avoir un champ de rétention. Je vais plus loin. Si je vais plus loin dans mon champ de rétention, je vais avoir un champ de détraction. Je suis avec toi ici. On a d'abord l'idée que c'est un muscle. Mais la tension est trop forte dans cette phase-là. On devient, tu tiens, pas encore, un ligament au-dessus, ou un fascia. Mais maintenant, on continue de plus en plus à se tirer. Et tu vois, ça fait comme ça. C'est comme si ça se détracte comme ça. Et on perd complètement la structure liquidienne et on devient un os. Et on perd ! Donc on a un champ ici, de nos uniques. de nos-denis, sur un autre Sur un autre plan, on peut avoir un champ de dilation. Ce champ de dilation, s'il est continu, il va donner un champ de rétention. Alors ça c'est tous les muscles, ça c'est tous les ligaments, tous les facia, ça ça donne tous les os. Et ça c'est une autre façon de l'os apparaître. Parce que vous avez vu, dans l'os,

on a vu qu'il y avait l'os membraneux et l'os cartilagineux. Alors tout dépend s'il va subir un champ de compression ou de décompression dans sa formation. La voûte, c'est un tissu qui se fait en grandissant. La base, c'est un tissu qui se fait en compression. Et là, on rajoute un autre champ métabolique. qu'on appelle les champs de contusion ou les champs de distension. En d'autres mots, ces champs-là, ce sont des champs, soit parce que les cellules sont comprimées, ça va donner les tissus cartilaginogènes, mais c'est aussi tout le mécanisme, la mise en place d'un tissu, d'un mouvement de croissance métabolique. Le champ de contusion et le champ de distension. Je suis en conclusion Ici ça va donner des différences d'épaisseur. C'était préféré. de tissus, ok ? Donc là on a un peu une image globale qu'il faut voir dans la croissance du développement où chaque tissu va atteindre un équilibre en fonction de son devenir et de sa situation corporelle de son génome et de son environnement dans sa force de croissance avec chacun va à un moment donné se maintenir, comme je vous ai dit si on va trop loin normalement j'aurai ici un tendon et puis si je vais trop loin ça va devenir une tendinite calcifiante donc je pars d'un champ de rétention vers quelque chose plus dense, je perds des qualités d'ordre métabolique sur le plan tissulaire ok ? Vous comprenez ? Et c'est là, notre rôle c'est de maintenir globalement ce principe homéostasique au travers de cette de ces champs embryonnaires Sous-titrage Société Radio-Canada primitifs qui organisent ce processus qui maintiennent, c'est là où toute cette force embryonnaire prend son sens qui est toujours là qui est un garant de cette homéostasie parce qu'elle atteint à un moment donné un équilibre et c'est là, c'est ce grand jeu d'équilibre qui se fait avec toujours cette référence pour maintenir sa puissance c'est un grand champ ici toi tu as le foie toi tu as l'estomac, vous êtes chacun un équilibre tout va bien vous êtes en harmonie en équilibre homéostasique par rapport au système il y en a un qui commence à

déconner Il y en a un qui commence à mal bouffer. Il commence à bouffer des crasses, des trucs. Il change son métabolisme. Les tissus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont répondre autrement. Et tout d'un coup, j'attrape une hépatomégalie. Putain, j'ai moins de sang qui passe. J'attrape une hypertension. J'attrape une hypertension, mon système nerveux commence à déconner. Et tu commences à partir. Et là-dessus, les tissus, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont d'abord essayer de se maintenir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut qu'on change un peu. Il a fallu un peu de tendinite là. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, bon. Le petit jeté, quoi. On va le dire qu'il va se calmer, puis le cœur commence à dégrader, puis le corps il veut rejeter au départ, il va faire, parce que tu as différents aimants que toi, il va utiliser différentes choses. D'abord il va essayer de faire sortir la maladie, puis s'il n'arrive pas, jusqu'à un moment donné, il va faire des néoformations. C'est tout des substrats, donc il faut essayer de retrouver les couches dans lesquelles on peut être, et d'aider la personne à recharger. Et on avait vu qu'à la base, c'était le premier cours, pratiquement la première diapositive importante, la chronologie d'apparition des systèmes de communication. Moi j'invite très souvent les gens, tous mes patients sortiront, et ils auront envie en tout cas d'essayer la médecine. J'essaye de les amener vers eux-mêmes. de les autochréniser. C'est juste. T'imagines, j'ai deux cellules ici qui poussent l'une contre l'autre. Il y a une mitose qui se fait. C'est un champ de contusion. Mais à un moment donné, un champ de contusion, ça pousse, ça va créer latéralement un champ de distusion. Donc c'est en fait simplement, tu dois juste retenir pour l'un, l'infini l'un fait des tissus cartilagineux jeunes, l'autre fait des tissus cartilagineux avant-après les jeunes. Le distusion va engendrer un champ. de corrosion ou qui va engendrer un champ d'oxygène, tout s'auto-équilibre. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, je vais commencer à faire ça. Et quand je développe, je rajoute tous les

champs. Et là, on commence à avoir tout d'un coup une espèce de... de mouvements des champs. Parce que ça, c'est juste vu sur un plan tissulaire. Après, vous avez toute l'organisation cellulaire, puis vous avez toute l'organisation moléculaire, puis vous avez toute l'organisation homéostasique, atomique, subatomique, et d'autres. Retenez vraiment cette phrase, le sacrum est à la base du développement cortical. Si le sacrum est libre, l'axe vertébral est libre. Si l'axe vertébral est libre, l'aspect médulaire est libre. Si le niveau médulaire est libre, le crâne est libre. Je, je, je, je, je, je... Le sacrum est quelque chose que je vérifie de chaque fois, de toute façon. point sacrum dégagé, par n'importe quel moyen que tu le fasses. Toutes les synchronicités, ça c'est une synchronicité importante ici déjà avec le péritoine, donc le tube neural c'est une articulation avec la cavité cardiopleuro-péritoneale, et on peut même dire que l'axe urogenital, de par son niveau de création, de par sa force mésodermique de développement, est l'articulation entre les deux. Le méso est l'articulation entre l'endo et l'ecto. Là il faut intégrer tout le système vasculaire pour vraiment avoir la compréhension de ce schéma. C'est l'importance du cerveau avec le foie, avec le cœur, avec les poumons, avec le plexus lésentérique et avec le système rénal. On développe, ça s'interfère dans le fonctionnement. Le micro-temps, ça c'est un peu plus tard. Ça c'est les synchronicités, ça c'est plus tard aussi, c'est pas maintenant.